

Impact des psychotropes sur le seuil convulsif

⚡ Le seuil convulsif (ou épileptogène) correspond au niveau d'activité électrique des neurones à partir duquel une crise convulsive peut se déclencher. Les médicaments psychotropes peuvent modifier ce seuil, et donc diminuer ou augmenter le risque de convulsion.

⚡ En général, ces effets n'ont aucune conséquence clinique, mais ils nécessitent une surveillance en particulier chez les personnes ayant des antécédents de convulsion ou d'autres facteurs de risque.

📈 Quand le seuil convulsif est élevé, le risque de crise convulsive diminue. Plusieurs psychotropes augmentent ce seuil :

- ☞ par définition, tous les anticonvulsivants à visée thymorégulatrice: lamotrigine, valpromide, valproate, carbamazépine, oxcarbazépine, topiramate, prégabaline
- ☞ toutes les benzodiazépines
- ☞ pour mémoire, le seuil convulsif augmente au fil des séances d'ECT, nécessitant un ajustement de la charge électrique

⚠ Un point essentiel: en cas d'arrêt rapide d'un médicament augmentant le seuil convulsif, ce seuil s'effondre, entraînant un risque majeur de crise convulsive.

- ☞ toujours arrêter progressivement ces traitements, surtout s'ils sont pris au long cours !
- ☞ prudence en cas de relais entre un médicament de la même classe abaissant le seuil et l'autre l'augmentant, par ex entre thymorégulateur anticonvulsivant et lithium, surtout si on arrête en même temps les benzodiazépines !

📉 Inversement, quand le seuil convulsif est bas, le risque de crise convulsive augmente. Plusieurs psychotropes diminuent ce seuil :

- ☞ antipsychotiques de 1^{ère} génération : toutes les phénothiazines (lévomépromazine, cyamémazine), contribuant à leur rapport bénéfice/risque défavorable, y compris et surtout dans les états d'agitation
- ☞ antipsychotiques de 2^{de} génération : clozapine surtout si l'introduction est trop rapide ou la clozapinémie trop élevée (> 600 ng/mL); le risque est plus faible avec l'olanzapine et la quétiapine
- ☞ antidépresseurs : surtout les tricycliques et le bupropion, et la venlafaxine à fortes doses
- ☞ lithium : surtout à doses élevées
- ☞ psychostimulants: à doses thérapeutiques, l'augmentation de risque est minime pour le méthylphénidate

📈 De nombreux autres facteurs augmentent le risque de convulsion :

- ☞ sevrage en alcool
- ☞ privation de sommeil
- ☞ troubles hydro-électrolytiques : hyponatrémie, hypocalcémie
- ☞ hypoglycémie
- ☞ hyperthermie (surtout chez les enfants)
- ☞ pathologies neurologiques (tumeur, AVC, trauma, etc.)

💡 Lorsqu'un psychotrope est efficace, la survenue d'une crise convulsive isolée contre-indique rarement sa poursuite :

- ☞ surtout si d'autres facteurs de risque modifiables sont présents
- ☞ en particulier avec la clozapine qui doit être poursuivie même en cas de répétition des crises : si la baisse des doses ne suffit pas, la lamotrigine est recommandée en 1^{er} ligne

💡 En cas d'épilepsie, la plupart des psychotropes peuvent en général être prescrits, incluant le lithium ou la clozapine s'ils sont indiqués. Cette prescription doit bien sûr se faire de manière concertée avec le médecin assurant le suivi de l'épilepsie.

Références

<https://doi.org/10.1016/j.ebr.2024.100679>

<https://www.sf-neuro.org/prise-en-charge-d-une-premi-re-crise-d-epilepsie-de-l-adulte/>

